

## 药物相互作用引起的严重不良反应

黑龙江省查哈阳农场职工医院 郑占山 赵青松 常绍玲 (查哈阳 162116)

各种药物单独作用于人体可产生一定的药理作用。当多种药物合并应用时,由于它们的相互作用,可使药效加强或副作用减轻,也可使药效减弱或出现不应有的毒、副作用。因此,在疾病的治疗过程中,既要考虑治疗效果,又要注意保证病人用药的安全。对由于药物相互作用而引起的严重不良反应,如高血压危象、出血、心律失常、呼吸麻痹、严重的低血压反应、低血糖反应、严重的骨髓抑制、耳聋等,分别论述如下。

### 1 高血压危象

药物相互作用引起严重的不良反应,如不加注意,可危及生命。如单胺氧化酶抑制剂(如优降宁、呋喃唑酮等)与麻黄碱、阿拉明、利他林等合用,可使去甲肾上腺素自贮存部位大量释放而出现高血压危象,并可致死。单胺氧化酶抑制剂与三环类抗抑郁药,左旋多巴合用亦能引起高血压危象。临床观察 15 例高血压危象病人,其中 6 例是应用三环类抑郁药后,进行牙科局麻,局麻药液内含有 0.4mg/ml 的去甲肾上腺素所引起的,因此应用三环类抗抑郁药后,局麻药液中不宜加入去甲肾上腺素或肾上腺素等血管收缩药。胍乙啶、苄甲胍、异唑胍等抗高血压药物均能经胺泵被摄取而进入肾上腺素能神经末梢的囊泡,从而阻止递质的释放,使血压下降。三环类抗抑郁药能抑制肾上腺素能神经末梢膜上的胺泵,妨碍药物被摄入末梢内,因而使之不能发挥降压作用,血压可迅速升高。

### 2 出血

2.1 香豆素类药物包括双香豆素,硝苄丙酮香豆素,苄丙酮香豆素等,为常用的口服抗凝药,它们与不少药物产生相互作用,从而增强药效,引起出血。例如:消胆胺,液体石蜡抑制维生素 K 由胃肠道吸收。氨基甙类抗生素、四环素、红霉素、头孢菌素类,磺胺类抑制肠道细菌,使维生素 K 合成减少。阿司匹林、消炎痛、布洛芬、萘普生、甲磺丁脲、氯磺丙脲、安妥明、苯妥英钠将与血浆蛋白结合的香豆素类置换出来。使血浆中游离型香豆素类浓度增高。甲氧咪胍、利他林、氯霉素抑制肝微粒体酶活性,减慢香豆素类的生物转化。阿司匹林、潘生丁抑制血小板聚集,与香豆素类发生协同作用。

2.2 肝素与阿司匹林、潘生丁合用,应十分谨慎,后者能抑制血小板聚集,合用后抗凝作用大大增强,有出血的危险,与利尿酸合用更易引起胃肠道出血。

### 3 心律失常

3.1 洋地黄类强心甙不宜与排钾利尿药或糖皮质激素合用。后者均可促进钾排出,使血钾降低。如失钾不纠正,则心脏对洋地黄类强心甙的作用更为敏感,易发生心律失常。

3.2 洋地黄类强心甙不宜与利血平合用,因两药均可使心动过缓,易诱发异位节律。

3.3 强心甙不宜与钙盐合用,特别禁忌注射钙盐,因为血钙升高可使心脏对强心甙的敏感性增强,易发生心律失常。

3.4 异搏定不宜与  $\beta$  肾上腺素受体阻滞剂合用。因用过  $\beta$  受体阻滞剂者静脉注射异搏定引起心动过缓、低血压、房室传导阻滞、心力衰竭,甚至心脏停搏。

### 4 呼吸麻痹

4.1 全身麻醉药(乙醚、硫喷妥钠、琥珀酰胆碱或硫酸镁)不宜与氨基甙类抗生素合用,因这类抗生素具有神经肌肉接点传递阻滞作用,注射时对呼吸作用更明显,故可引起呼吸麻痹。

4.2 氨基甙类抗生素与普鲁卡因酰胺合用时可加强神经肌肉接点阻滞作用,引起肌无力和呼吸麻痹。

4.3 利多卡因可加强琥珀酰胆碱的骨骼松弛作用,合用时可引起呼吸麻痹。

4.4 环磷酰胺能抑制伪胆碱脂酶的活性,使琥珀胆碱不易灭活,从而加强其骨骼松弛作用。两药合用有可能导致呼吸麻痹。

### 5 严重低血压反应

5.1 氯丙嗪不宜与双氢克尿塞、速尿、利尿酸等合用,这些利尿药均具有降压作用,可以明显增强氯丙嗪的降压反应,引起严重的低血压。

5.2 心得安不宜与氯丙嗪或哌唑嗪合用,心得安可阻滞  $\beta$  肾上腺受体,氯丙嗪与哌唑嗪则阻滞  $\alpha$  肾上腺素受体,两药合用降压效果明显增强。

### 6 低血糖反应

6.1 磺丁脲不宜与长效磺胺类、水杨酸类、保泰松、速尿等合用,这些药物与血浆蛋白结合率高,可将与血浆蛋白结合的甲磺丁脲置换出来,使血中游离型甲磺丁脲浓度升高,降血糖作用明显增强,从而引起低血糖反应。保泰松还能抑制肝微粒体酶对甲磺丁脲的代谢,亦能增强药效。

6.2 氯霉素能明显抑制肝微粒体酶对甲磺丁脲的代谢,使甲磺丁脲的血浓度提高,降血糖作用明显增强。合用时如不减低甲磺丁脲的剂量,可引起低血糖反应。

6.3 抗糖尿病药物不宜与心得安合用,两者合用除可加重低血糖反应外,并可将抗糖尿病引起的急性低血糖先兆症状掩盖起来,从而危险性更大。胍乙啶也能加强抗糖尿病药的降糖作用,合用时抗糖尿病药应减量,否则易引起低血糖反应。

### 7 严重骨髓抑制

7.1 甲氨喋呤不宜与水杨酸类、磺胺类和速尿合用,后者可以从血浆蛋白结合部位将甲氨喋呤置换出来,血中游离型甲氨喋呤浓度升高,对骨髓抑制明显增强,可引起全血细胞减少及血质不调。

7.2 别嘌呤醇不宜与硫唑嘌呤,6-巯嘌呤合用,别嘌呤醇抑制黄嘌呤氧化酶,使后两种药代谢减慢,血浓度提高,对骨髓抑制加强。如需合用,必须把硫唑嘌呤 6-巯嘌呤的用量减少。别嘌呤醇亦可能加强环磷酰胺对骨髓的抑制作用,其机制待探讨。

### 8 耳聋

8.1 利尿酸、速尿不宜与氨基甙类抗生素合用,两者在听神经损害方面有相加作用。合用后耳聋的发生率明显增加,尤其在尿毒症病人更易发生。

8.2 氨基甙类抗生素不宜与抗组织胺药合用,抗组织胺药可掩盖这类抗生素的听神经毒性症状,不易及时发现。

故此在某种疾病的治疗过程中,医生处方用药,应既要考虑治疗效果,又要保证病人用药的安全,把握合理用药,一定不

可滥用。

(1998—05—12 收稿)

## 新生儿几种常见特殊表现鉴别与处理

南京农业大学农业工程学院卫生所 徐贞勇 (南京 210032)

新生儿期,婴儿脱离了母体的内环境,降生到世界这个新的环境之中,由于环境的改变,机体产生一系列的生理性变化,有些生理性的改变,却表现为病理性的表现。如何认识新生儿这些正常的生理性改变和与之相应的病理性改变的区别,对于新生儿的健康成长有十分重要的意义。

### 1 新生儿生理性黄疸

新生儿出生之后,由于肺呼吸的建立,使之原有红细胞过剩,因此出生之后红细胞大量的破坏,血清内间接胆红素浓度增高,加之婴儿肝内葡萄糖醛酸转换酶不足,处理间接胆红素的能力不足,使大量的间接胆红素储留体内,而出现黄疸。

因此新生儿出生后出现黄疸是正常的生理现象,称之为生理性黄疸。一般情况下,约有 80% 正常新生儿有此现象,一般是在出生 2~3 日开始,7~10 日后消退。有些早产儿,黄疸出现可晚 1~2 天,程度较重,消退时间可延长到 2 周以上。除出现黄疸之外,婴儿一般情况良好,大便颜色正常,尿色也不加深,无其他临床表现。

新生儿期除了上述生理性黄疸之外,还有不少的疾病可以引起黄疸,如新生儿溶血症、新生儿肺炎、新生儿败血症及其他感染、先天性胆道闭锁等。如果新生儿黄疸出现过早(出生 24h 内),或过晚(出生 1 周之后),黄疸过深,延长过长时间或过后又出现黄疸,应引起重视,是否有病理性黄疸的可能,应即时全面检查,找出病因,以便及早对症治疗。

新生儿黄疸一般无需特殊处理,但对黄疸较深和早产儿,除加强日常护理之外,注意供给足够的葡萄糖和水分,对避免胆红素过高有一定作用。还可适当治疗或口服活性炭,加速胆红素的氧化分解和减少胆道对胆红素的吸收,此外避免应用大剂量维生素 K,防止溶血产生,避免使用磺胺,防止胆红素不能和蛋白结合,注意影响葡萄糖醛酸转换酶的药物的应用,如水杨酸盐、氯霉素、新生霉素等。

### 2 新生儿脱水热

新生儿在出生 3~4 天后突然发热,有时体温可高达 38.5~40℃,但一般情况良好,吮乳正常,有时可出现烦躁不安,囟门凹陷等脱水症状,只要给足水分,体温数小时内可降到正常,这种暂时地发热现象我们称之为“一过热”,一般认为是由于水分补充不足和体表丧失所致,又称为“脱水热”。新生脱水热的原因是由于新生儿尤其未成熟儿,体温不恒定,易受外界环境的影响改变,新生儿脱离胎内羊水环境之后,由于室温过高,进水过少,加之婴儿体表面积相对小,水分不显性损失等,这是发生

新生儿脱水热的主要原因。

新生儿脱水热主要补足水分,体温迅速恢复正常,这一点与其它原因的发热鉴别最为重要,对于发热不退伴有拒奶的新生儿应考虑感染性疾病的可能性,必须即时进一步处理。

对新生儿脱水热,不需作特殊处理,只要即时补充水分,可 2~3h 喂 20ml 葡萄糖水或白开水,一般很快体温就可以恢复正常。

### 3 新生儿生理性体重减轻

新生儿在出生后的最初几天,几乎所有的新生儿都有体重减轻的现象,尤其是在出生 3~4 天体重下降最快,一般下降 6%~10%,最多不超过 10%,但新生儿从第 5 天开始体重迅速增加,至出生第 8 天最迟不超过半个月体重可恢复到出生时体重水平,新生儿这种体重减轻与恢复有一定规律,不能称作病态,因此称为生理性体重减轻。

新生儿体重下降的原因,是因为新生儿出生后,通过肺呼吸和皮肤的蒸发,如室温过高,保暖过度均可使水分散失,大小便的排泄,水分损失较多,而新生儿出生之后 8~12h 才开始哺乳,有时产妇初乳不足,是补充水分不足,这些因素均可成为新生儿体重下降的重要原因。

因此我们对新生儿体重减轻的现象要足够的重视,要加强新生儿的喂养和护理,主张尽早母乳喂养,如母乳不足,应注意人工喂养,补充热量和水平,防止和减轻新生儿体重下降,对迟迟不能恢复到出生时水平的新生儿应寻找原因,如母乳不足、喂养不当和其他新生儿疾病等。

### 4 新生儿“马牙”、上皮珠

新生儿口腔上腭正中线附近或硬腭交界处,往往有数个散在性的黄白色小结节称为上皮珠,是由于上皮细胞堆集而成。新生儿牙龈正常有黄白色颗粒,亦系上皮细胞堆积而成,俗称“马牙”,这些都是正常的生理现象,但在我们的日常生活中,由于卫生知识缺乏和过去老的习惯的影响,在全国各地特别是广大农村均有挑治新生儿“马牙”的不良习惯,经常造成严重的后果。我们知道新生儿口腔粘膜很娇嫩,挑治“马牙”,往往是造成新生儿败血症的罪魁祸首。

对新生儿“马牙”、上皮珠不需特殊处理,只需加强新生儿的口腔护理,在喂奶之后让新生儿喝少许白开水,用以清除口腔内奶液等,保持口腔清洁,必要时用棉签沾生理盐水轻擦口腔,绝不能用力,防止损害口腔粘膜,造成新生儿感染。